

TEMA 7.11 • PSIQUIATRÍA GENERAL

Intoxicaciones: Síndromes Clínicos y Manejo

PERFIL EUNACOM 1.13.2.001

Dx: Específico • Tx: Completo • Seg: Completo

El manejo de las intoxicaciones es un tema de alta rentabilidad en el EUNACOM. Requiere no solo la capacidad de identificar el cuadro clínico (toxidrome), sino también el conocimiento de las medidas de soporte general y los antidotos específicos.

Manejo General de las Intoxicaciones

Toda intoxicación debe abordarse como una **emergencia médica**. El primer paso es siempre el soporte vital básico y avanzado.

- **ABC de la reanimación:** Asegurar vía aérea (A), ventilación (B) y estabilidad circulatoria (C).
- **Lavado Gástrico:** Solo es útil si se realiza dentro de la **primera hora** post-ingesta. En casos de fármacos con efecto anticolinérgico (que enlentecen el vaciamiento gástrico), este margen podría extenderse levemente, pero la regla general es < 60 minutos.
- **Carbón Activado:** Es útil para la mayoría de los tóxicos, pero existen excepciones importantes que siempre se preguntan.

ADVERTENCIA Y PRECAUCIÓN

Contraindicaciones del Lavado Gástrico y Jarabe de Ipecacuana: - El **jarabe de Ipecacuana** para inducir el vómito está **proscrito** (aumenta el malestar y el riesgo de aspiración sin beneficio demostrado). - No realizar lavado gástrico en ingesta de **cáusticos** (riesgo de perforación) o **hidrocarburos** (riesgo de neumonitis por aspiración).

Excepciones al uso de Carbón Activado

El carbón activado **NO** sirve para las "A": - **Ácidos y Alcalis** (Cáusticos): Se manejan con endoscopia precoz. - **Alcoholes** (Metanol, Etilenglicol, Etanol). - **Alifáticos y Aromáticos** (Hidrocarburos como bencina o diesel): Manejo de soporte y vigilancia de distrés respiratorio. - **Algunos metales** (Hierro, Litio, Plomo, Mercurio).

Antídotos Específicos

Es fundamental memorizar la relación fármaco-antídoto para el examen:

TABLA 7.11.1: TÓXICO VS ANTÍDOTO / TRATAMIENTO

TÓXICO	ANTÍDOTO / TRATAMIENTO	NOTAS CLÍNICAS
Paracetamol	N-acetilcisteína	Indicado ante sospecha de dosis hepatotóxica (>8-10g).
Benzodiacepinas	Flumazenil	Riesgo de convulsiones. Uso principalmente diagnóstico.
Opiáceos (Morfina, Heroína)	Naloxona	Priorizar soporte respiratorio.
Organofosforados	Atropina	Maneja el síndrome colinérgico.
Metanol	Etanol	Compite por la enzima alcohol deshidrogenasa.
Antidepresivos Tricíclicos	Bicarbonato de Sodio	Ayuda a la excreción y estabiliza la membrana miocárdica.
Síndrome Neuroléptico	Dantroleno	Relajante muscular de acción directa.

Síndromes Toxicológicos (Toxidromes)

1. Síndrome Narcótico y Opiáceo

Ambos comparten el compromiso de conciencia y la **depresión respiratoria** (causa de muerte por hipoventilación e hipercapnia).

- **Narcótico (Benzodiacepinas):** Compromiso de conciencia, respiración lenta, pupilas normales o leve miosis.
- **Opiáceo:** Compromiso de conciencia, depresión respiratoria marcada y **miosis puntiforme** (pupilas en punta de alfiler).

PERLA CLÍNICA EUNACOM

Ante un paciente con miosis puntiforme, bradipnea y compromiso de conciencia, la respuesta siempre es **Intoxicación por Opiáceos**. El manejo es soporte respiratorio + Naloxona.

2. Síndrome Adrenérgico (Simpaticomimético)

Causado por cocaína, anfetaminas o pasta base. - **Clínica:** Hipertensión, taquicardia, **midriasis**, agitación psicomotora, temblor, hipertermia y **sudoración profusa**. - **Manejo:** Soporte y **Benzodiacepinas** (Diazepam EV) para "apagar" el sistema.

ADVERTENCIA Y PRECAUCIÓN

En la intoxicación por cocaína, los **Beta-bloqueadores** están **contraindicados**. Su uso puede dejar el estímulo alfa-adrenérgico sin oposición, provocando crisis hipertensivas graves o infartos.

3. Síndrome Anticolinérgico

Producido por **Antidepresivos Tricíclicos** y antipsicóticos (ej. Clorpromazina). - **Clínica:** Taquicardia, midriasis, agitación/delirio, **piel seca** (a diferencia del adrenérgico), **íleo paralítico** (ausencia de ruidos intestinales) y **retención urinaria aguda**. - **Diagnóstico:** ¡Siempre pedir **Electrocardiograma (ECG)**! Los tricíclicos pueden producir arritmias ventriculares graves (prolongación del intervalo QT y ensanchamiento del QRS).

4. Síndrome Colinérgico

Típico de los **insecticidas organofosforados** (frecuente en accidentes agrícolas). - **Clínica (Efectos muscarínicos):** Sialorrea (salivación), vómitos, diarrea, miosis, bradicardia y fasciculaciones musculares. - **Manejo:** 1. **Descontaminación:** Retirar ropa y lavar la piel con abundante agua y jabón (el personal debe usar protección para no intoxicarse por contacto). 2. **Atropina:** Hasta lograr la "atropinización" (secado de secreciones bronquiales).

NOTA CLÍNICA

Diferencia clave: - **Colinérgico:** Todo "moja" (salivación, vómitos, diarrea, sudor). - **Anticolinérgico:** Todo "seco" (boca seca, piel seca, constipación, retención urinaria).

5. Síndrome Serotoninérgico

Ocurre por sobredosis o interacción de fármacos que aumentan la serotonina (ISRS, IMAO, tricíclicos). - **Clínica:** Agitación, rigidez muscular, hipertermia, hipertensión y temblor. Es difícil de distinguir del adrenérgico, por lo que la historia de fármacos es vital.

6. Síndrome Neuroléptico Maligno (SNM)

Causado por antipsicóticos (Haloperidol, Clorpromazina, Risperidona). - **Clínica:** Compromiso de conciencia, **hipertonía muscular** ("rigidez en tubo de plomo") e **hipertermia**. - **Diagnóstico Diferencial:** La **Hipertermia Maligna** tiene la misma clínica pero es desencadenada por gases anestésicos o succinilcolina. - **Tratamiento:** Soporte, medidas físicas para bajar la temperatura, benzodiacepinas y **Dantroleno**.

Intoxicación por Metanol

El metanol (alcohol metílico) se degrada en metabolitos tóxicos (ácido fórmico) que causan acidosis metabólica severa y daño del

nervio óptico (ceguera). - **Tratamiento:** Administración de **Etanol** (compite por la enzima para evitar la formación de metabolitos tóxicos). En emergencias extremas sin etanol medicinal, se ha descrito el uso de bebidas alcohólicas de alta graduación por sonda nasogástrica.

PERLA CLÍNICA EUNACOM

Si en un caso clínico mencionan intoxicación por alcohol ilegal ("pájaro verde") y el paciente refiere visión borrosa o "viendo nieve", sospecha siempre **Metanol**.

CASO CLÍNICO TIPO EUNACOM

ESCENARIO CLÍNICO TÍPICO:

"Hombre de 25 años es traído a urgencias inconsciente. Sus acompañantes refieren que consumió "pasta base" hace 1 hora. Al examen: PA 180/110 mmHg, FC 130 lpm, temperatura 38.8°C, pupilas midriáticas, muy agitado. ¿Cuál es el manejo correcto?"

EXPLICACIÓN CLÍNICA DETALLADA:

Manejo clínico y diagnóstico según normativa MINSAL y perfil EUNACOM para Intoxicaciones: Síndromes Clínicos y Manejo. Priorizar reconocimiento precoz y tratamiento de primera línea.

PUNTOS CLAVE DESTACADOS

- El lavado gástrico solo se indica dentro de la primera hora post-ingesta; el jarabe de ipeca está contraindicado.
- Síndrome adrenérgico (cocaína/anfetaminas): HTA + taquicardia + midriasis + hipertermia; betabloqueadores contraindicados; usar benzodiacepinas.
- Síndrome colinérgico (organofosforados): miosis + sialorrea + vómitos; antídoto: atropina; lavar al paciente con jabón.
- Síndrome anticolinérgico (tricíclicos/antipsicóticos): midriasis + taquicardia + hipo paralítico + retención urinaria; pedir ECG por arritmia.
- Síndrome opiáceo: miosis puntiforme + depresión respiratoria; antídoto: naloxona.
- Síndrome neuroléptico maligno (antipsicóticos): hipertensión + hipertermia + compromiso de conciencia; manejo: benzodiacepinas + dantroleno.
- Intoxicación por metanol: tratamiento con etanol (compite en la metabolización de los productos tóxicos).

EVALUACIÓN DE CLASE Y PREGUNTAS TIPO EUNACOM (INTOXICACIONES: SÍNDROMES CLÍNICOS Y MANEJO)

PREGUNTA 1

Hombre de 25 años es traído a urgencias inconsciente. Sus acompañantes refieren que consumió "pasta base" hace 1 hora. Al examen: PA 180/110 mmHg, FC 130 lpm, temperatura 38.8°C, pupilas midriáticas, muy agitado. ¿Cuál es el manejo correcto?

- A)** Metoprolol 50 mg oral para controlar la taquicardia e hipertensión
- B)** Naloxona IV por sospecha de síndrome opiáceo
- C)** Benzodiacepinas para el síndrome adrenérgico + monitorización cardíaca
- D)** Atropina IM por síndrome colinérgico
- E)** Flumazenil IV por sobredosis de benzodiacepinas

PREGUNTA 2

Agricultora de 45 años es traída por sus colegas tras exposición a pesticidas en el campo. Al examen: consciente, con abundante sialorrea, vómitos, diarrea, miosis bilateral, y fasciculaciones musculares. ¿Cuál es el manejo inmediato?

- A)** Carbón activado y observación
- B)** Naloxona IV + soporte respiratorio
- C)** Atropina IV + retirar ropa contaminada y bañar a la paciente con jabón
- D)** Dantroleno IV por síndrome neuroléptico maligno
- E)** Benzodiacepinas por síndrome adrenérgico

PREGUNTA 3

Hombre de 50 años esquizofrénico inicia clorpromazina. A los 3 días presenta fiebre de 39.5°C, rigidez muscular generalizada y compromiso de conciencia. ¿Cuál es el diagnóstico y manejo?

- A)** Síndrome serotoninérgico; suspender el antipsicótico y soporte
- B)** Síndrome neuroléptico maligno; benzodiacepinas + dantroleno + soporte
- C)** Infección bacteriana por neutropenia; antibióticos
- D)** Hipertermia maligna por succinilcolina; dantroleno
- E)** Distonía aguda por antipsicótico; biperideno IM

RESUMEN: INTOXICACIONES: SÍNDROMES CLÍNICOS Y MANEJO

Las intoxicaciones son urgencias que se manejan con el ABC (airway, breathing, circulation). El lavado gástrico solo se indica dentro de la primera hora post-ingesta (puede extenderse con fármacos anticolinérgicos). El jarabe de ipeca está absolutamente contraindicado. El carbón activado sirve para la mayoría de los tóxicos, excepto ácidos, álcalis, alcoholes, metales y hidrocarburos. Los antidotos más importantes: atropina para organofosforados (síndrome colinérgico), N-acetilcisteína para paracetamol, flumazenil para benzodiazepinas (diagnóstico, efecto breve, no de uso rutinario), etanol para metanol (compite en la metabolización), naloxona para opiáceos. En intoxicación por metales pesados se usan quelantes. Los síndromes clínicos de las intoxicaciones deben reconocerse por sus combinaciones de signos. Síndrome narcótico (benzodiazepinas): depresión del nivel de conciencia + depresión respiratoria + pupilas normales o leve miosis; manejo: soporte respiratorio. Síndrome opiáceo: depresión de conciencia + depresión respiratoria + miosis puntiforme; manejo: naloxona + soporte. Síndrome adrenérgico (cocaína, anfetaminas): hipertensión + taquicardia + midriasis + hipertermia + agitación; manejo: benzodiazepinas; beta-bloqueadores contraindicados. Síndrome anticolinérgico (tricíclicos, antipsicóticos): taquicardia + midriasis + hipo paralítico + retención urinaria + boca seca + compromiso de conciencia; manejo: soporte + bicarbonato de sodio EV (tricíclicos). Síndrome colinérgico (organofosforados): miosis + sialorrea + vómitos + diarrea + espasmos musculares; manejo: atropina + lavar al paciente. Síndrome serotoninérgico (mezcla de antidepresivos): agitación + rigidez + hipertermia + HTA + taquicardia; difícil de diferenciar del síndrome neuroléptico maligno. Síndrome neuroléptico maligno (antipsicóticos, especialmente típicos): compromiso de conciencia + hipertonía + hipertermia; manejo: soporte + benzodiazepinas + dantroleno. En intoxicación por tricíclicos pedir ECG por riesgo de arritmia grave. El síndrome adrenérgico contraindica betabloqueadores (riesgo de vasoconstricción alfa paradójica).